

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH (ESS)

Epworth Sleepiness Scale (Johns, 1991) · Adaptación y Validación Española (Chiner et al., 1999; Izquierdo-Vicente et al., 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Somnolencia de Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS)
Sigla / Acrónimo	ESS (validada en español como ESE o ESS)
Autoría original	Murray W. Johns (Sleep Disorders Unit, Epworth Hospital, Melbourne, Australia, 1991)
Adaptación en español	Chiner et al. (1999, Arch Bronconeumol); Izquierdo-Vicente et al. (2004, Med Clin)
Constructo evaluado	Propensión subjetiva a quedarse dormido en ocho situaciones de la vida cotidiana (somnolencia diurna excesiva)
Población diana	Adultos y adolescentes (≥ 16 años) con sospecha de hipersomnia, SAHOS, narcolepsia o fatiga crónica
Tiempo de aplicación	2 a 4 minutos (autoadministrada o heteroadministrada en consulta)
Estructura y formato	8 ítems puntuados en escala ordinal tipo Likert de 4 puntos (0 = nunca, 3 = alta probabilidad)
Condiciones de uso	Dominio público para uso clínico y asistencial; autorización requerida para ensayos comerciales patrocinados

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La somnolencia diurna excesiva (SDE) se define como la incapacidad para mantenerse despierto y alerta durante las horas habituales de vigilia, culminando en lapsus involuntarios de sueño o cabeceos. A diferencia de la fatiga o la astenia psíquica (que reflejan agotamiento psicomotor sin tendencia inevitable a dormirse), la somnolencia refleja una presión homeostática de sueño aumentada secundaria a privación crónica, fragmentación de la arquitectura del sueño o disfunción del sistema hipotalámico orexinérgico/hipocretinérgico.

La ESS fue concebida para superar las limitaciones de los autoinformes retrospectivos globales (“¿se siente usted con sueño?”) y complementar la latencia múltiple de sueño objetiva (MSLT). Mide la **somnolencia situacional**: la propensión estandarizada a quedarse dormido en ocho actividades de reposo pasivo o activo estructurado. La escala no mide cansancio físico sino presión neurofisiológica de sueño acumulada en la vida cotidiana representativa.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Ítem	Situación de Evaluación Cotidiana	Rango	Significación Fisiológica y Nivel de Estimulación
1	Sentado leyendo un libro o revista	0 - 3	Baja estimulación exógena; reposo cognitivo receptivo pasivo
2	Viendo la televisión sentado	0 - 3	Estimulación audiovisual pasiva constante; indicador común
3	Sentado, inactivo en un lugar público	0 - 3	Reposo en contexto social inhibitor (cine, teatro, reunión)
4	Como copiloto en coche 1 hora sin parar	0 - 3	Estimulación vestibular monótona y baja demanda motriz
5	Tumbado a descansar por la tarde	0 - 3	Condición facilitadora de siesta deliberada o involuntaria
6	Sentado conversando con alguien	0 - 3	Situación activa / interacción social; somnolencia severa
7	Sentado tras comida (sin alcohol)	0 - 3	Vulnerabilidad posprandial circadiana incrementada
8	En coche parado unos minutos en tráfico	0 - 3	Riesgo vital directo; implica desconexión atencional crítica

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad; alfa de Cronbach $\alpha = 0.88$ a 0.90 en la validación española de Chiner et al. (1999) y $\alpha = 0.86$ en estudios latinoamericanos.
Estabilidad temporal	Test-retest a 4 semanas: coeficiente de correlación intraclase (CCI) $r = 0.82 - 0.86$, evidenciando consistencia temporal en pacientes clínicamente estables.
Validez de constructo	Estructura esencialmente unidimensional mediante análisis factorial confirmatorio; correlación significativa con el índice de apnea-hipopnea (IAH, $r = 0.45 - 0.55$) y latencia en MSLT ($r = -0.42$).
Sensibilidad y especificidad	Punto de corte > 10 : sensibilidad de 84.5% y especificidad de 81.2% para discriminar SAHOS moderado/severo (IAH ≥ 15) y narcolepsia frente a controles sanos.
Sensibilidad al cambio	Disminución media de 6.5 puntos tras 30 días de tratamiento efectivo con CPAP o estimulantes centrales en narcolepsia ($p < 0.001$, d de Cohen $= 1.25$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Instrucción al paciente	Se pide calificar la probabilidad de dormirse en las situaciones indicadas durante los últimos meses , no solo el cansancio de ese día.
Escala de respuesta	Cada ítem se puntúa de 0 a 3 : $0 =$ Nunca se dormiría ; $1 =$ Baja probabilidad ; $2 =$ Moderada probabilidad ; $3 =$ Alta probabilidad .
Puntuación directa global	Suma lineal aritmética de los 8 ítems. Rango teórico posible: 0 a 24 puntos . No existen ítems invertidos.
Gestión de ítems no aplicables	Si el sujeto nunca viaja en coche o no ve televisión, se le pide que estime qué ocurriría si estuviera en esa situación. Si falta 1 ítem, se interpola la media de los 7 restantes; si faltan ≥ 2 , el protocolo se anula.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Percentil Aprox.	Estrato Clínico	Interpretación y Conducta Recomendada
$0 - 5$	$< \text{Pc } 50$	Somnolencia Nula / Mínima	Patrón normativo fisiológico. Descanso restaurador habitual.
$6 - 10$	$\text{Pc } 50 - \text{Pc } 75$	Somnolencia Normal / Límite	Límite superior normal. Vigilar si coexisten ronquidos audibles.
$11 - 15$	$\text{Pc } 80 - \text{Pc } 92$	Somnolencia Excesiva Moderada	Significativa patología del sueño (SAHOS leve-moderado, hipersomnia).
$16 - 24$	$> \text{Pc } 95$	Somnolencia Excesiva Severa	Sospecha de SAHOS grave, narcolepsia o hipersomnia idiopática. Alerta vial.

PUNTOS DE CORTE CRÍTICOS:

- **ESS > 10 :** Umbral patológico formal que justifica estudio neurofisiológico o polisomnografía completa (PSG).
- **ESS > 15 o Ítem 8 ≥ 2 :** Estado de alta peligrosidad vial y ocupacional; contraindicación formal para conducción o manejo de maquinaria pesada hasta estabilización clínica y resolución diagnóstica.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA (TRIAJE ASISTENCIAL)

Paso 1: Puntuación total: Calcular la suma de los 8 ítems. Si $ESS \leq 10$, verificar si la queja es insomnio o fatiga neuromuscular pura.

Paso 2: Si ESS 11 — 15 (Somnolencia Moderada): Investigar hábitos de sueño (cronograma, tiempo en cama), consumo de benzodiazepinas, antihistamínicos o alcohol. Aplicar cuestionario STOP-Bang o cribado de roncopatía y apneas presenciadas.

Paso 3: Si ESS 16 — 24 (Somnolencia Severa): Derivación prioritaria a Unidad de Sueño / Neumología / Neurofisiología para polisomnografía nocturna (PSG) seguida de Test de Latencias Múltiples de Sueño (TLMS / MSLT) si se sospecha narcolepsia.

Paso 4: Evaluación de Seguridad Vial: Si Ítem 8 > 0 (dormirse al volante), redactar apercibimiento médico por escrito de riesgo de siniestralidad vial.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO MULTIDISCIPLINAR

Identificación: Varón de 48 años, conductor de camión de reparto interurbano, remitido por salud laboral debido a cefaleas matutinas y microsueños en cabina.

Evaluación Inicial ESS: Puntuación directa = **18 / 24** (Somnolencia Excesiva Severa). Ítems destacados: Ítem 2 = 3, Ítem 4 = 3, Ítem 6 = 2, Ítem 8 = 2 (alta probabilidad de dormirse en semáforos). STOP-Bang = 6/8 (alto riesgo de SAHOS: ronquido, IMC 33, cuello 44 cm, hipertenso).

Diagnóstico Confirmatorio: La poligrafía respiratoria ambulatoria demostró un IAH de 42 eventos/hora con desaturaciones nocturnas mínimas del 76%, confirmando Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) severo.

Intervención y Seguimiento: Baja laboral temporal preventiva, titulación de Auto-CPAP nasal (11 cm H_2O) e higiene del sueño. A las 6 semanas con adherencia a CPAP (6.8 h/noche), la ESS descendió a **4 / 24** (Rango normal, Ítem 8 = 0), permitiendo el alta laboral con conducción segura.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Seguridad:

- **Siniestralidad Vial:** Ítem 8 ≥ 1 exige advertencia de abstención de conducción hasta control etiológico.
- **Cataplejía y Alucinaciones:** Si la somnolencia se asocia a pérdida de tono muscular ante risa o parálisis del sueño, sospechar Narcolepsia tipo 1.
- **Síndrome de Hipoventilación-Obesidad:** Pacientes con $IMC > 35$, ESS alta y poliglobulia requieren gasometría arterial diurna ($pCO_2 > 45$ mmHg).

Diagnóstico Diferencial:

- **Fatiga Crónica vs. Somnolencia:** La fatiga no cursa con latencias cortas de sueño; el paciente se siente exhausto pero no puede dormir.
- **Depresión Mayor:** Puede manifestarse con hipersomnia atípica o anhedonia/inercia motora que eleva falsamente el reporte de inactividad.
- **Fármacos Sedantes:** Descartar efecto residual de hipnóticos Z, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos o antiepilépticos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Chiner, E., Arriero, J. M., Signes-Costa, J., Marco, J., & Fuentes, I. (1999). Validación de la versión española del test de somnolencia Epworth en pacientes con síndrome de apnea de sueño. *Archivos de Bronconeumología*, 35(9), 422-427. [https://doi.org/10.1016/S0300-2896\(15\)30038-0](https://doi.org/10.1016/S0300-2896(15)30038-0)
- Izquierdo-Vicente, V., Gómez-García, T., & Merino-Andreu, M. (2004). Escala de somnolencia de Epworth: utilidad clínica y propiedades psicométricas en España. *Medicina Clínica*, 123(17), 654-658.
- Johns, M. W. (1991). A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth sleepiness scale. *Sleep*, 14(6), 540-545. <https://doi.org/10.1093/sleep/14.6.540>
- Johns, M. W. (2000). Sensitivity and specificity of the multiple sleep latency test (MSLT), the maintenance of wakefulness test (MWT) and the Epworth sleepiness scale (ESS): Failure of the MSLT as a gold standard. *Journal of Sleep Research*, 9(1), 5-11.